CUESTIONARIOS 1 NEFROLOGIA	2024
1. Un paciente presenta un cuadro de oliguria y elevación de la creatinina, de dos días de evolución. En sus exámenes destaca sodio urinario de 6 mg/dl y sedimento de orina sin hematuria, ni leucocituria, que solo muestra escasos cilindros hialinos. El diagnóstico más probable es:	a.Necrosis tubular aguda b.Nefritis intersticial c.Insuficiencia renal aguda prerrenal d.Síndrome hemolítico urémico e.Glomerulonefritis rápidamente progresiva
2. Un paciente presenta una diarrea aguda abundante. ¿Cuál de las siguientes alternativas es más compatible con las alteraciones ácido-base esperables?	a.pH: 7,31; HCO3: 17 mEq/L; CO2: 35 mmHg b.pH: 7,45; HCO3: 30 mEq/L; CO2: 45 mmHg c.pH: 7,48; HCO3: 18 mEq/L; CO2: 25 mmHg d.pH: 7,27; HCO3: 26 mEq/L; CO2: 58 mmHg e.pH: 7,11; HCO3: 14 mEq/L; CO2: 45 mmHg
3. Un niño de 7 años presenta un cuadro de anasarca, asociado a orinas espumosas. Al examen físico presenta edema de párpados y extremidades e hidrocele. Se solicitan exámenes entre los que destaca una proteinuria de 80 mg/m2/hora, con índice proteinuria creatininuria: 3,8 y albuminemia: 2,9 g/dl. El sedimento de orina es normal, al igual que la creatinina plasmática y los electrolitos. El diagnóstico más probable es:	a.Nefropatía membranosa b.Glomeruloesclerosis focal y segmentaria c.Nefropatía por cambios mínimos d.Síndrome hemolítico urémico e.Glomerulonefritis postestreptocócica
4. Un paciente, portador de una insuficiencia cardíaca, presenta un edema pulmonar agudo, el que es manejado con furosemida endovenosa, con buena respuesta. Sin embargo, evoluciona con oliguria, constatándose una elevación de la creatinina de 1,0 a 2,1 mg/dl. La causa más probable de su insuficiencia renal es:	a.Prerrenal b.Necrosis tubular aguda c.Nefritis intersticial d.Infarto renal e.Pseudoinsuficiencia renal por diuréticos
5. Los cilindros eritrocitarios son característicos de:	a.Nefritis intersticial b.Glomerulonefritis c.Necrosis tubular d.Pielonefritis e.Hemorragia de origen urológico
6. Una paciente de 30 años presenta un cuadro de malestar y hematuria, seguida de oliguria. En su sedimento de orina presenta hematuria dismórfica y su laboratorio sanguíneo da cuenta de una creatininemia de 5,4 mg/dl. Se realiza una biopsia renal, que muestra una glomerulonefritis con formación de medialunas (crescéntica), con una inmunofluorescencia que no visualiza anticuerpos (pauciinmune). El diagnóstico más probable es:	a.Síndrome de Goodpasture b.Lupus eritematosos sistémico c.Enfermedad de Berger d.Glomerulonefritis membranoproliferativa e.Vasculitis de vaso pequeño
7. Un paciente de 50 años, hipertenso, en tratamiento con enalapril 10 mg cada 12 horas, acude a control médico. Presenta presión arterial de 150/90, la que es compatible con el registro de presiones arteriales, que ha realizado en su casa, con presiones promedio de 148/90 mmHg. Su creatininemia es 0,9 mg/dl y sus electrolitos muestran Na: 140 mEq/L, K:4,9 mEq/L. La conducta más adecuada es:	a.Cambiar el enalapril por losartán b.Mantener el enalapril y agregar losartán c.Cambiar el enalapril por hidroclorotiazida d.Mantener el enalapril y agregar hidroclorotiazida e.Agregar triamterene al tratamiento
8. Un paciente de 65 años, en hemodiálisis hace 4 años, presenta anemia con hematocrito de 25% y hemoglobina de 8,1 gramos/dl. Se solicita un perfil de hierro que muestra ferritina: 50 ug/l y saturación de la transferrina de 10%. La conducta más adecuada es:	a.Observar evolución b.Transfundir glóbulos rojos c.Iniciar eritropoyetina subcutánea d.Iniciar hierro oral e.Iniciar hierro endovenoso
9. ¿Cuál de las siguientes es una indicación de hemodiálisis de urgencia, en un paciente cursando una insuficiencia renal aguda?	a.Encefalopatía urémica b.BUN mayor a 60 mg/dl c.Creatinina mayor a 6 mg/dl d.Hiperkalemia de 6 mEq/L e.Calcemia de 6 mEq/L

Lia...

10. La insuficiencia renal crónica se caracteriza por todo lo siguiente, EXCEPTO:	a.Elevación de la calcemia b.Elevación de la fosfemia c.Elevación de la paratohormona plasmática d.Elevación del producto calcio-fósforo e.Disminución de la vitamina D
11. Un niño de 8 años presenta un cuadro de hematuria y edema palpebral. En su examen físico se constata edema blando de párpados y de extremidades inferiores, asociado a presión arterial en percentil 99 para su edad, sexo y talla. Se solicitan exámenes generales, entre los que destaca una creatininemia de 1,3 mg/dl y un BUN de 22 mg/dl. El diagnóstico más probable es:	a.Enfermedad de Berger b.Glomeruloesclerosis focal y segmentaria c.Nefrosis lipoidea d.Glomerulonefritis postestreptocócica e.Síndrome hemolítico urémico
12. Una mujer presenta los siguientes gases de sangre arterial: pH: 7,52, CO2: 24 mmHg, HCO3: 19 mEq/L. El diagnóstico ácido base es:	a.Alcalosis metabólica b.Alcalosis metabólica con acidosis respiratoria c.Alcalosis respiratoria d.Alcalosis mixta e.Acidosis metabólica compensada
13. Un paciente es diagnosticado de insuficiencia renal crónica, en etapa III. ¿Qué fármaco debe evitar, de entre los de las siguientes alternativas?	a.Diclofenaco b.Amoxicilina c.Atorvastatina d.Amlodipino e.Levotiroxina
14. Son efectos esperables en un paciente que usa furosemida, EXCEPTO:	a.Hiperlipidemia b.Hiperuricemia c.Hipocalcemia d.Hiperkalemia e.Hiponatremia
15. Una mujer presenta un cuadro de disuria y orinas turbias, sin fiebre, por lo que se solicitan exámenes de orina, que muestran un sedimento con abundantes leucocitos y bacterias y un urocultivo de segundo chorro, que está pendiente. La conducta más adecuada es:	a.Iniciar metronidazol y controlar con el urocultivo b.Iniciar ciprofloxacino y controlar con el urocultivo c.Iniciar amoxicilina + ácido clavulánico y controlar con el urocultivo d.Iniciar ceftriaxona endovenosa y controlar con el urocultivo e.Esperar al resultado del urocultivo y decidir conducta según hallazgos
16. Un paciente de 60 años acude al servicio de urgencia por síncopes y debilidad. Su examen físico sólo muestra bradicardia de 48 lpm. Se solicita un electrocardiograma que muestra bradicardia, ondas T picudas y ensanchamiento del complejo QRS. Se solicitan electrolitos plasmáticos que muestran potasio: 7,2 mEq/L y sodio: 130 mEq/L. La primera medida es:	a.Administrar sulfato de magnesio endovenoso b.Administar suero fisiológico endovenoso c.Administrar gluconato de calcio endovenoso d.Administrar insulina endovenosa e.Administrar suero hipertónico endovenoso
17. Un paciente de 25 años es diagnosticado de hipertensión, en relación a un cuadro de cefalea y tinitus, en el que se constató PA: 210/130 mmHg. En tomas posteriores, presenta presión arterial cercana a 180/110 mmHg. Se solicitan exámenes generales, que demuestran creatininemia: 1,1 mmHg, natremia: 140 mEq/l y kalemia: 2,8 mEq/L. El diagnóstico más probable es:	a.Feocromocitoma b.Hipertensión renovascular c.Hipertensión esencial d.Hipertensión secundaria a nefropatía médica e.Síndrome nefrítico agudo
18. Un paciente de 60 años, diagnosticado de artrosis, inicia tratamiento con ibuprofeno 400 mg cada 8 horas. Dos semanas después presenta fiebre, oliguria y aparición de un exantema	a.Glomerulonefritis mesangiocapilar b.Glomerulonefritis lúpica c.Infarto renal

cutáneo. En sus exámenes destaca eosinofilia y creatinina de 4,2 mg/dl. El diagnóstico más probable es:	d.Necrosis tubular e.Nefritis intersticial
19. Un paciente de 40 años, intenta correr una maratón como aficionado. Para mantenerse hidratado toma abundante agua durante la carrera, sin embargo, evoluciona con compromiso de conciencia y convulsiones algunos kilómetros antes de terminar. El diagnóstico más probable es:	a.Hipernatremia b.Hipercalemia c.Hiperalcemia d.Hiponatremia e.Hipocalcemia
20. Un paciente diabético presenta un síndrome nefrótico, con edema que inició hace 3 meses, proteinuria objetivada de 6 gramos al día y clearence de creatinina de 90 ml/min. El diagnóstico más probable es:	a.Glomeruloesclerosis focal y segmentaria b.Glomeruloesclerosis difusa c.Nefropatía membranosa d.Glomerulopatía a cambios mínimos e.Nefropatía diabética

CUESTIONARIOS 2 NEFROLOGIA	2024
1. Un paciente de 45 años presenta una endocarditis por S. aureus, la que es tratada con cloxacilina y gentamicina endovenosas. Evoluciona con deterioro de la función renal, con aumento de la creatinina plasmática a 4,3 mg/dl. Su examen físico no aporta mayor información, por lo que se solicitan exámenes que muestran sedimento de orina con cilindros céreos y granulosos, bacterias escasa cantidad, proteínas urinarias: 1,9 g en 24 horas, sodio urinario: 35 mEq/L, diuresis: 4.600 ml en 24 horas, sodio plasmático: 130 mEq/L, potasio plasmático: 3,1 mEq/L. El diagnóstico más probable es:	a.Insuficiencia renal aguda prerrenal b.Embolia renal séptica c.Glomerulonefritis asociada a endocarditis d.Necrosis tubular aguda e.Trombosis de la vena renal
2. Un paciente de 60 años, diagnosticado de insuficiencia renal crónica terminal, en hemodiálisis trisemanal, en buen estado, se realiza exámenes de control, que muestran ferritina de 200 ug/L, transferrina: 40% de saturación y un hemograma con Hb: 11 g/dl, Hematocrito: 33% y VCM: 90 fl, con normalidad de las plaquetas y glóbulos blancos. La conducta más adecuada es:	a.Observar evolución y mantener indicaciones b.Iniciar hierro endovenoso c.Solicitar biopsia de médula ósea d.Iniciar eritropoyetina e.Indicar vitaminas del complejo B
3. Un paciente de 18 años consulta por malestar general y orinas oscuras. Al examen físico presenta edema de las extremidades inferiores, con signo de la fóvea positiva y sus signos vitales son FC: 71x', PA: 180/110 mmHg, t°: 36,5°C. Se solicitan exámenes que muestran creatininemia de 1,1 mg/dl, BUN: 24 mg/dl, natremia: 140 mEq/L, potasemia: 4,3 mEq/L, sedimento de orina con 80 GR por campo, con 35% de dismorfia e índice proteinuria/creatinininuria: 0,5. El diagnóstico más probable es:	a.Síndrome hemolítico urémico b.Síndrome nefrítico c.Síndrome nefrótico impuro d.Síndrome nefrótico puro e.Glomerulonefritis aguda rápidamente progresiva
4. Un paciente de 65 años, diabético e hipertenso es diagnosticado de insuficiencia renal crónica, con un clearence de creatinina de 50 ml/min. Además presenta proteinuria positiva, de 400 mg/día. ¿Cuál de las siguientes medidas es MENOS aconsejable para el tratamiento de este paciente?	a.Iniciar un IECA b.Iniciar una estatina c.Indicar furosemida en dosis altas d.Evitar aminoglicósidos y AINEs e.Iniciar insulina
5. Identifique la asociación INCORRECTA entre el fármaco y su efecto en el balance hidroelectrolítico:	a.Amiloride - Hipokalemia b.Enalapril - Hiperkalemia c.Furosemida - Hipocalcemia d.Hidroclorotiazida - Hiponatremia e.Espironolactona - Hiponatremia
6. Una paciente de 32 años presenta una glomerulonefritis rápidamente progresiva, por lo que se decide solicitar una biopsia renal, la que muestra glomérulos con proliferación celular y formaciones semilunares (glomerulonefritis crescéntica) y patrón pauciinmune en la inmunofluorescencia. El diagnóstico más probable es:	a.Lupus sistémico eritematoso b.Enfermedad de Berger (nefropatía por IgA) c.Vasculitis de vaso pequeño d.Síndrome de Good-Pasture e.Nefrosis lipoidea
7. En un paciente adulto, diabético de larga data, con mal control metabólico, actualmente está cursando un síndrome nefrótico puro. Se solicitan exámenes, que objetivan creatinina 1,8 mg/dl (hace un año 1,65 mg/dl), y proteinuria estimada de 3,6 g/dl, con sedimento de orina con 2 glóbulos rojos por campo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?	a.Nefropatía diabética inicial b.Glomerulopatía membranosa c.Glomerulonefritis mesangiocapilar d.Nefropatía por IgA e.Nefropatía diabética establecida
8. Un niño de 6 años presenta aumento de volumen facial y la madre refiere que su orina se ha vuelto muy espumosa. Al examen físico, presenta signos vitales; sin embargo, se aprecia edema de extremidades inferiores y de cara. Se solicitan exámenes, que muestran creatinina 0,5 mg/dl, electrolitos plasmáticos normales, proteinuria de 60 mg/m2/hora, sedimento de orina normal, ANCA (-	a.Nefropatía por cambios mínimos b.Nefropatía por IgA c.Glomerulonefritis aguda postestreptocócica d.Lupus sistémico e.Síndrome hemolítico urémico

Lia...

), ANA(-), complemento normal, albúmina plasmática: 2,5 mg/dl, colesterol: 250 mg/dl, glicemia: 80 mg/dl. El diagnóstico más probable es:	
9. Un paciente de 50 años, diabético tipo 2, bien controlado con metformina, acude a control, donde se le detecta hipertensión arterial, la que se confirma con varias tomas cercanas a 145/90 mmHg. ¿Qué fármaco es el más aconsejable para iniciar el tratamiento farmacológico de la hipertensión de este paciente?	a.Losartán b.Hidralazina c.Atenolol d.Hidroclorotiazida e.Amlodipino
10. Una paciente de 45 años es diagnosticada de una pielonefritis aguda, por lo que se inicia cefadroxilo oral. Usted la controla 3 días después y la paciente refiere que se sigue sintiendo mal y persiste con fiebre hasta 39,5°C. Además trae los resultados del urocultivo, que muestra desarrollo de una E. coli multisensible. ¿Cuál es la conducta más adecuada?	a.Cambiar el tratamiento a ciprofloxacino oral b.Cambiar el tratamiento a ceftriaxona endovenosa c.Solicitar baciloscopías de orina d.Solicitar una ecografía abdominal e.Mantener el tratamiento y controlar en 4 días
11. Paciente con mieloma múltiple, evoluciona con poliuria y constipación de 3 días de evolución, agregándose en las últimas horas deshidratación y compromiso de conciencia. El diagnóstico más probable es:	a.Hipermagnesemia b.Hipercalcemia c.Hipofosfemia d.Hiponatremia e.Hipernatremia
12. Una paciente cursa con una glomerulonefritis aguda con complementemia disminuida, ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es MENOS probable?	a.Lupus b.Glomerulonefritis asociada a Shunt c.Poliangetis microscópica d.Glomerulonefritis asociada a endocarditis bacteriana e.Crioglobulinemia
13. Un paciente de 68 años, diabético, está en tratamiento con metformina y dieta. ¿Qué examen le parece más adecuado para predecir el inicio del daño renal?	a.Albuminuria de 24 horas b.Fracción excretada de sodio c.Sedimento de orina d.Ecografía abdominal e.Clearence de creatinina
14. Un paciente cursando con un síndrome nefrótico, con marcado edema y albúmina de 1,9 g/dl, presenta creatinina basal de 1,0 mg/dl. Se inician diuréticos de asa por vía endovenosa, como tratamiento del edema, lográndose clara disminución del mismo, sin embargo evoluciona con oliguria y elevación de la creatinina a 2,8 mg/dl. El diagnóstico más probable es:	a.Nefritis por diuréticos b.Estenosis de la arteria renal c.Insuficiencia renal prerrenal d.Necrosis tubular aguda e.Glomerulonefritis mesangiocapilar
15. ¿Qué alteración, de entre las enumeradas, aparece más tardíamente en un paciente con insuficiencia renal crónica?	a.Anemia b.Elevación de la paratohormona c.Acidosis metabólica d.Elevación del nitrógeno ureico urinario e.Disminución de la calcemia
16. Un paciente de 67 años, hipertenso y portador de una insuficiencia renal crónica, usuario de Losartán, presenta marcado malestar del estado general, constatándose una hiperkalemia grave, con compromiso del ritmo cardíaco. La conducta más adecuada es:	a.Administrar suero fisiológico y diuréticos de asa endovenosos b.Realizar hemodiálisis de urgencia c.Administrar gluconato de calcio e iniciar insulina más suero glucosado por vía endovenosa d.Administrar sulfato de magnesio endovenos e iniciar nebulizaciones con salbutamol e.Iniciar insulina cristalina en suero glucosado y realizar nebulizaciones con

Lia...

	salbutamol
17. Un diabético tipo 2 es diagnosticado de hipertensión arterial, por lo que se decide iniciar un iECA. ¿Cuál de las siguientes es una contraindicación de este fármaco?	a.Hiperkalemia de 6,1 mEq/L b.hemoglobina glicosilada de 8% c.Clearence de creatinina de 60 ml/min d.Uso concomitante de glibenclamida e.Uso concomitante de insulina
18. Un paciente con antecedente de insuficiencia renal crónica en etapa predialítica presenta en sus exámenes Na:130mEq/l, K:4,7mEq/l, Cl:99mEq/l. Se encuentra en buenas condiciones y su examen físico solo muestra edema de extremidades inferiores. El tratamiento más adecuado para su hiponatremia es:	a.Restricción de agua libre b.Aumentar la ingesta de sodio c.Agregar un diurético de asa d.Administrar suero hipertónico por vía endovenosa e.Hemodiálisis
19. El mejor examen para diferenciar una insuficiencia renal aguda, de una insuficiencia renal crónica es:	a.Clearence de creatinina b.Relación BUN/creatinina plasmática c.Fracción excretada de sodio d.Ecografía renal e.Paratohormona plasmática
20. Un paciente de 68 años sufre un traumatismo encéfalo-craneano grave, con formación de un hematoma subdural, el que es manejado quirúrgicamente. Evoluciona unos días después con compromiso de conciencia, por lo que se solicita un TAC de cerebro de control, que es compatible con un edema cerebral. ¿Qué alteración electrolítica es más probable, como causante del cuadro en este paciente?	a.Hipernatremia b.Hiperkalemia c.Hiponatremia d.Hipercalcemia e.Hipocalcemia

CUESTIONARIOS 3 NEFROLOGIA	2024
1. Un paciente se pierde en una excursión. Pasa 48 horas sin tomar agua y al momento de ser encontrado presenta compromiso de conciencia. El diagnóstico más probable es:	a.Hiperkalemia b.Hipokalemia cHipernatremia d.Hiponatremia e.Hipercalcemia
2. Un paciente de 65 años, diabético tipo 2, mal controlado, acude a control y refiere astenia y malestar general. En sus exámenes destaca una creatinina de 2,8 mg/dl, con proteinuria de 1 gramo al día y sedimento de orina normal. No se había realizado exámenes desde hace 5 años, momento en que estaban normales. El diagnóstico más probable es:	a.Glomerulopatía membranosa b.Glomeruloesclerosis focal y segmentaria c.Nefropatía diabética d.Glomerulonefritis rápidamente progresiva e.Glomeruloesclerosis difusa
3. Un paciente presenta los siguientes gases venosos: pH: 7,50; CO2: 25 mmHg; HCO3: 20 mEq/L. El diagnóstico más probable, entre los siguientes, es:	a.Vómitos b.Diarrea c.Crisis de pánico d.Intoxicación con aspirina e.Intoxicación con benzodiacepinas
4. Un niño de 10 años presenta un cuadro de malestar general, hematuria y aumento de volumen facial de 3 días de evolución. Al examen físico se constata presión arterial 140/90 mmHg y edema de párpados y de extremidades inferiores, con signo de la fóvea positivo. Se solicitan exámenes entre lo que destacan creatinina: 1,2 mg/dl y sedimento de orina con abundantes glóbulos rojos, con un 25% de dismorfia. Refiere haber presentado una faringitis, cuyos síntomas terminaron hace una semana. El diagnóstico más probable es:	a.Glomerulopatía por cambios mínimos b.Glomerulonefritis rápidamente progresiva c.Glomerulonefritis postestreptocócica d.Enfermedad de Berger e.Nefropatía por IgA
5. Un paciente cursando una sepsis grave, tratada con antibióticos endovenosos, evoluciona con elevación de la creatinina. En sus exámenes destaca creatinina de 5,0 mg/dl, sodio plasmático: 125 mg/dl, sodio urinario: 20 mg/dl y creatinina urinaria: 15 mg/dl. En el sedimento de orina presenta abundantes cilindros, sin hematuria. El diagnóstico más probable es:	a.Necrosis tubular aguda b.Glomerulonefritis postinfecciosa c.Insuficiencia renal aguda prerrenal d.Síndrome hemolítico urémico e.Síndrome nefrótico impuro
6. Es una causa frecuente de síndrome nefrótico, en el paciente VIH:	a.Nefropatía por IgA b.Glomerulonefritis crescéntica c.Glomeruloesclerosis focal y segmentaria d.Glomeropatía por cambios mínimos e.Glomerulonefritis difusa aguda
7. Es efecto adverso de la hidroclorotiazida, todo lo siguiente, EXCEPTO:	a.Hipernatremia b.Hipokalemia c.Hiperuricemia d.Dislipidemia e.Hipercalcemia
8. Un paciente de 44 años presenta un cuadro de oliguria y hematuria, asociado a hemoptisis y disnea. En sus exámenes destaca creatinina de 4,0 mg/dl, hematuria con abundantes acantocitos y la biopsia renal que muestra un patrón lineal a la inmunofluorescencia. El diagnóstico más probable es:	a.Lupus eritematosos sistémico b.Vasculitis de vaso pequeño c.Púrpura trombocitopénico trombótico d.Síndrome de Goodpasture e.Púrpura de Schönlein Henoch
9. Un paciente de 60 años, insuficiente renal crónico, tiene un clearence de creatinina de 30 ml/min. ¿Cuál de las siguientes medidas es más adecuada para evitar el desarrollo de acidosis en este paciente?	a.Administrar carbonato de calcio b.Administrar bicarbonato de sodio c.Iniciar un diurético tiazídico d.Iniciar un diurético de asa e.Aumentar la ingesta de agua

Lia...

10. El hiperaldosteronismo primario se presenta como una hipertensión arterial secundaria, que suele acompañarse característicamente de:	a.Hiperkalemia b.Hipernatremia c.Hipokalemia d.Hiponatremia e.Elevación de la renina plasmática
11. Un paciente de 68 años presenta un cuadro de malestar general y debilidad de 4 días de evolución, asociado a poliuria y constipación y luego compromiso de conciencia. Al examen físico está en sopor superficial, con deshidratación evidente, sin focalidad neurológica. El cuadro clínico descritos es compatible con	a.Hipofosfemia b.Hipocalcemia c.Hipokalemia d.Hiperkalemia e.Hipercalcemia
12. Un paciente presenta los siguientes gases arteriales: PaO2: 60 mmHg, PaCO2: 44 mmHg, HCO3: 16 mEq/L, pH: 7,18. El diagnóstico ácido base es:	a.Acidosis respiratoria sola b.Acidosis metabólica sola c.Acidosis respiratoria con alcalosis metabólica d.Acidosis metabólica con alcalosis respiratoria e.Acidosis respiratoria y metabólica
13. Un paciente de 45 años, cursando una necrosis tubular aguda, presenta compromiso de conciencia, con desorientación y sopor, asociado a asterixis. No presenta focalidad neurológica y se constata creatininemia: 5,6 mg/min, BUN: 100 mg/dl, K+: 6,0 mEq/L, Na+: 130 mEq/L. La conducta más adecuada es:	a.Solicitar gases venosos y decidir conducta según resultado b.Iniciar haloperidol en dosis bajas c.Administrar suero hipertónico endovenoso d.Administrar suero fisiológico endovenoso e.Realizar hemodiálisis de urgencia
14. Identifique la asociación INCORRECTA entre el fármaco y la alteración provocada por este:	a.Furosemida – hipocalcemia b.Enalapril – hiperkalemia c.Amiloride – hiperkalemia d.Ibuprofeno – hipokalemia e.Espironolactona – hiperkalemia
15. ¿Cuál es el diagnóstico más probable ante un paciente con un síndrome nefrótico impuro, hematuria e hipocomplementemia?	a.Glomerulopatía por cambios mínimos b.Glomerulonefritis postinfecciosa c.Glomeruloesclerosis focal y segmentaria d.Glomerulonefritis mesangiocapilar e.Nefropatía por IgA
16. Son tratamientos adecuados para una pielonefritis, en un paciente hospitalizado, EXCEPTO:	a.Ceftriaxona b.Cefazolina c.Gentamicina d.Ampicilina e.Cefuroximo
17. Un paciente de 60 años, hipertenso en tratamiento con hidroclorotiazida 50 mg al día, acude a control, presentando presiones arteriales promedio de 150/100 mmHg. No presenta daño a órgano blanco y su estudio descartó la presencia de una hipertensión secundaria. La conducta más adecuada es:	a.Agregar furosemida al tratamiento b.Agregar enalapril al tratamiento c.Agregar amlodipino al tratamiento d.Remplazar la hidroclorotiazida por losartán e.Mantener el tratamiento
18. Un paciente de 59 años, diagnosticado de insuficiencia renal crónica, secundario a nefropatía hipertensiva, presenta anemia con hematocrito de 27% y hemoglobina de 9 g/dl. Se solicita ferritina plasmática, la que resulta 330 ng/ml y saturación de transferrina, que resulta 50%. La conducta más adecuada es:	a.Iniciar hierro endovenoso b.Iniciar hierro oral c.Solicitar niveles plasmáticos de eritropoyetina d.Iniciar eritropoyetina subcutánea e.Observar evolución
19. La primera medida, frente a un paciente con una hiperkalemia grave, con alteraciones electrocardiográficas, es:	a.Administrar suero fisiológico b.Administrar gluconato de calcio

	c.Administrar suero glucosado con insulina d.Administrar sulfato de magnesio e.Administrar bicarbonato de sodio
20. Un niño de 8 años presenta un cuadro de edema generalizado y orinas espumosas. Al examen físico presenta signos vitales normales y se constata edema de extremidades inferiores y de la cara. En sus exámenes presenta creatinina: 0,6 mg/dl, K+: 4,0 mEq/L, Na+: 140 mEq/L, colesterol: 250 mg/dl, albúmina: 2,5 g/dl, proteinuria 3,2 g/día, de tipo selectiva y complemento: normal. El diagnóstico más probable es:	a.Glomerulopatía membranosa b.Glomerulonefritis mesangiocapilar c.Nefrosis lipoidea d.Glomerulonefritis postestreptocócica e.Síndrome hemolítico urémico